L'ANNONCE DE LA MALADIE GRAVE

Pr DJELLALI
Faculté de Médecine Béjaia

Notions Générales

Psychologie :

Discipline scientifique qui étudie les conduites des êtres vivants :

–Processus mentaux (pensées)

– Emotions (ressentis)

– Comportements (agis)

au travers de l'observation :

– du comportement psychomoteur,

– des processus psychiques (fonctions psychologiques) :

perception, apprentissage, mémoire, pensée, langage, motivations, émotions,

Notions générales

Psychologie médicale

Champ de la psychologie s'intéressant aux aspects psychologiques personnels et interpersonnels en relation avec la maladie

o le malade et sa maladie:

- prédisposition à la maladie
- réactions psychologiques à la maladie

o la fonction soignante (le médecin et son malade):

aspects relationnels : relation médecin-malade

L’annonce de la maladie grave
Objectifs

1- Améliorer la relation entre le professionnel de santé et le patient.

2- Savoir se comporter de façon appropriée lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie grave.

3- Apporter des principes de prise en charge valables pour une grande diversité de maladies graves.

Introduction

Une annonce n’est pas toujours préparée :

- Préparation de la ou des consultations d’annonce,
- Le temps de l’annonce proprement dit,
- L’accompagnement,

Par ailleurs; il y’a des temps d’errance, d’absence de certitude, liés à la nature des affections,

Contextes et définitions

- **Maladie:** altération des fonctions de la santé de l'organisme, animal ou végétal,
- **Maladie chronique:**

Se définit en fonction des conséquences de la maladie sur l'état de santé,

La diagnostic ne permet pas toujours de trancher sur le caractère chronique ou aigu du processus pathologique,

Le sujet de la maladie chronique

De nombreux termes sont utilisés pour désigner celui/celle qui souffre de maladie chronique :

- **Patient,** est le terme médical historique et juridique (avec malade); il a l 'avantage de ne pas réduire l 'individu à sa seule maladie.

- **Malade,** ce terme tend à faire oublier l'être humain qui porte cette maladie, et par là oublier les autres déterminants psychiques, sociaux et culturels de l'individu.

- **Personne,** a une connotation juridique et citoyenne forte. Ce terme renvoie à la dignité de la personne humaine, à la dimension de droit (et de devoir) inaliénable de chaque individu devant la loi.

- **Personne malade,** est le terme actuellement le plus souvent utilisé.

Préalables à l 'annonce du diagnostic

A/ Eléments liés au Patient :

- Son histoire (situation familiale, activité professionnelle), son réseau d'aides mobilisables, etc.
- Les ATCD familiaux de la maladie à annoncer notamment,
- Les ATCD personnels (incidence somatique et psychologique d’une ou plusieurs autres maladies chroniques),
- Ses difficultés d'expression et/ou de compréhension.
- Ses croyances, son contexte socioculturel et financier.
- Une connaissance suffisante de la personnalité du patient, ses craintes et les éléments contextuels (deuil récent, maladie du conjoint, hospitalisation, stabilité de sa sphère affective, etc.).
- Le vécu du ou des proches aidants,

B/ Eléments liés à la maladie et au contexte :

- Notion d'urgence.
- Stade évolutif de la maladie,
- Pronostic fonctionnel,
- Impact de la maladie sur le mode de vie de la personne,
- Possibilités thérapeutiques, protocole thérapeutique éventuel,
- Incertitude du diagnostic, traitement d'épreuve éventuel,
- Gravité, incertitude du pronostic.

C/ Penser au projet de soins

Avant de procéder à I 'annonce, il est conseillé d'avoir envisagé concrètement **les possibilités de mise en place du projet thérapeutique**, notamment vis-à-vis des enjeux que cela représente pour le patient, sa vie quotidienne et ses projets personnels et professionnels.

Annonce du diagnostic

ll est important que le médecin soit disponible et prenne le temps nécessaire pour :

- Rappeler les informations déjà connues (la raison de cette rencontre, les plaintes ou les difficultés initiales, les examens complémentaires préalablement pratiqués, etc)
- Être à l'écoute du patient, être attentif à ses réactions,
- L'aider à mettre des mots sur son ressenti ou à poser les questions qui le préoccupent,
- Evaluer la réceptivité du patient : après l'annonce, vérifier ce qui a été entendu et ce que cela génère pour le patient,
- Prendre en considération les souhaits et les projets du patient (personnels et professionnels) et de son entourage ;
- Proposer si nécessaire d'autres entretiens.

Comment annoncer

• Annoncer une maladie chronique est un temps essentiel de la relation de soin :

l'objectif est de faire **évoluer la relation soignant-soigné** vers une relation de confiance et de transparence.

• Deux aspects spécifiques à ce guide de premier recours sont développés ci-dessous :

- I 'impact psychique de l'annonce d'une maladie chronique,

- la détermination du médecin qui annonce le diagnostic.

Les points suivants peuvent aussi être abordés :

- Parler des causes de la maladie et, si c'est le cas, des différentes formes évolutives, sans être alarmiste,
- Evoquer les possibilités de recours à différents médecins spécialistes d'organe susceptibles d'intervenir,
- Utiliser des mots clairs et appropriés, réfléchir à une graduation dans le choix des mots ou a contrario aux termes à éviter.
- En fonction du rythme d'appropriation du patient; l'annonce peut se dérouler sur plusieurs consultations si cela est nécessaire.

Accompagnement de l'annonce

- Le patient et éventuellement son aidant et ses proches doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, être revus rapidement après l'annonce par le médecin qui a fait le diagnostic,
- Il doit être donné au patient et éventuellement à son aidant et ses proches les informations nécessaires pour leur permettre de faire cet accompagnement (qui joindre?, quand et comment?)

Décider avec le patient ? La décision médicale partagée

- Elle comporte une première étape de partage, communication et délibération.

Le patient renseigne le médecin sur ses symptômes physiques, psychiques, sur sa situation personnelle et professionnelle, en retour le médecin informe le patient sur les bilans pratiqués, sur les différents traitements envisageables, les évolutions probables, etc.

Le patient reçoit ainsi le soutien nécessaire pour envisager les différentes options possibles et exprimer ses préférences.

- La deuxième étape est celle de la décision de la mise en œuvre de l 'option choisie grâce au choix éclairé et accepté d'un commun accord.

L'annonce, un temps d'appropriation:

En règle générale, I 'annonce du diagnostic ou d'un état d'aggravation, vécu par le patient comme un un choc.

• Le patient, passe d'un état **d'ignorance** ou de suppositions à **une réalité,**

•Le vécu peut être très différent en fonction de la personne, en fonction de sa personnalité, de son milieu socioculturel, de la gravité effective et ressenti et de **représentations de la maladie**,

•Il s'agit dans tous les cas d'appréhender une nouvelle réalité, d'autant plus brutale que le patient se découvre dépendant d'un traitement lourd, d'un traitement à vie, confronté à une **perte d'autonomie** déjà présente ou à venir,

• le patient peut se croire plus atteint, par exemple proche de mourir, qu'il ne l’est réellement du fait de sa maladie.

• A contrario, certains patients seront soulagés de poser des mots sur leur diagnostic (effet positif de nommer la maladie, source d'angoisse, etc.).

• D'une part, nommer la maladie et ses principales conséquences

est nécessaire ; le patient (et parfois ses aidants) doit prendre conscience de la réalité de son état médical afin de :

• percevoir pleinement ses enjeux personnels et sociaux
• pour y remédier au mieux
• suivre activement son traitement et ceux à venir.

Pour le médecin

Ce temps d'assimilation a des contraintes et limitations que l'état médical du patient occasionne (et/ou va occasionner), est souvent difficilement vécu par les soignants.

En effet, ce temps peut se traduire par une agressivité dirigée envers les soignants ou envers ses proches, voire par un déni de la maladie.

• Les professionnels de santé peuvent aussi éprouver une frustration, voire un sentiment de culpabilité, de leur incapacité à soigner ou guérir, voire à soulager.

• Cependant, le médecin doit nommer la maladie, désignation indispensable à la personne pour qu'elle puisse se l'approprier.

• Le médecin s'adressant à un patient dans sa singularité, l'annonce doit être adaptée à **sa disponibilité psychique et cognitive,**

Cependant, il ne faut pas donner de faux espoirs en amoindrissant la portée du diagnostic ou la réalité du pronostic.

D'autre part, il faut s'efforcer de réaliser cette annonce de façon à **atténuer autant que possible la brutalité ressentie** des informations (qui risqueraient de ce fait d'être non comprises, déformées, oubliées, etc.).

- Annoncer est donc un exercice subtil car le médecin **doit trouver un discours approprié au patient, ni dramatisé ni banalisé.**
- Le médecin doit savoir reconnaître que dans certains cas, rester dans l'incertitude peut être pour le patient une lutte contre le désespoir : une annonce d'abord limitée (non exhaustive) peut permettre de passer un premier temps de sidération ou déni.